



МОЗ УКРАЇНИ
ДЕРЖАВНА УСТАНОВА «ЛЬВІВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ЦЕНТР
КОНТРОЛЮ ТА ПРОФІЛАКТИКИ ХВОРОБ
МІНІСТЕРСТВА ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я УКРАЇНИ»
(ДУ «ЛЬВІВСЬКИЙ ОЦКПХ МОЗ»)
ЗОЛОЧІВСЬКИЙ РАЙОННИЙ ВІДДІЛ

вул. В. Івасюка, 13, м. Золочів, Львівської області, 80700, тел. (03265) 4-33-61 E-mail: zolochivcdc@gmail.com

Код ЄДРПОУ 38501853

Керівникам закладів охорони здоров'я
Золочівського району

Щодо захворюваності окремими
інфекційними хворобами, які мають
значення для громадського здоров'я.

Золочівський районний відділ ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ» висловлює Вам свою
повагу та надає статистичні дані за 33 тиждень 2026 року щодо захворюваності в країнах
Європейського регіону окремими інфекційними хворобами, що мають важливе значення
для громадського здоров'я.

Інформація ґрунтується на матеріалах EuroCDC.

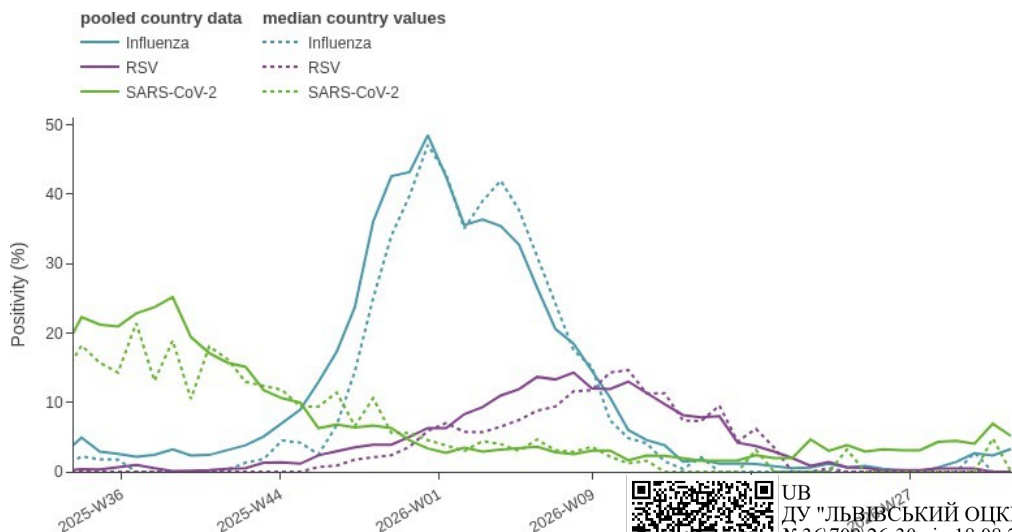
Прошу довести надані матеріали (додатки) до відома ЗОЗ, працівників
відповідальних органів пунктів перетину державного кордону, туроператорів,
організацій, які здійснюють міжнародні перевезення, тощо, використовувати для
інформаційно-роз'яснювальної роботи серед населення щодо попередження
розповсюдження інфекційних хвороб, у тому числі тих, що мають міжнародне значення.

Огляд епідеміології респіраторних вірусів у ЄС/ЄЕЗ, тиждень 31, 2026

ECDC контролює рівень респіраторних захворювань та активність вірусу в
ЄС/ЄЕЗ. Результати представлені в Європейському звіті про епіднагляд за
респіраторними вірусами (ERVISS.org), який оновлюється щотижня.

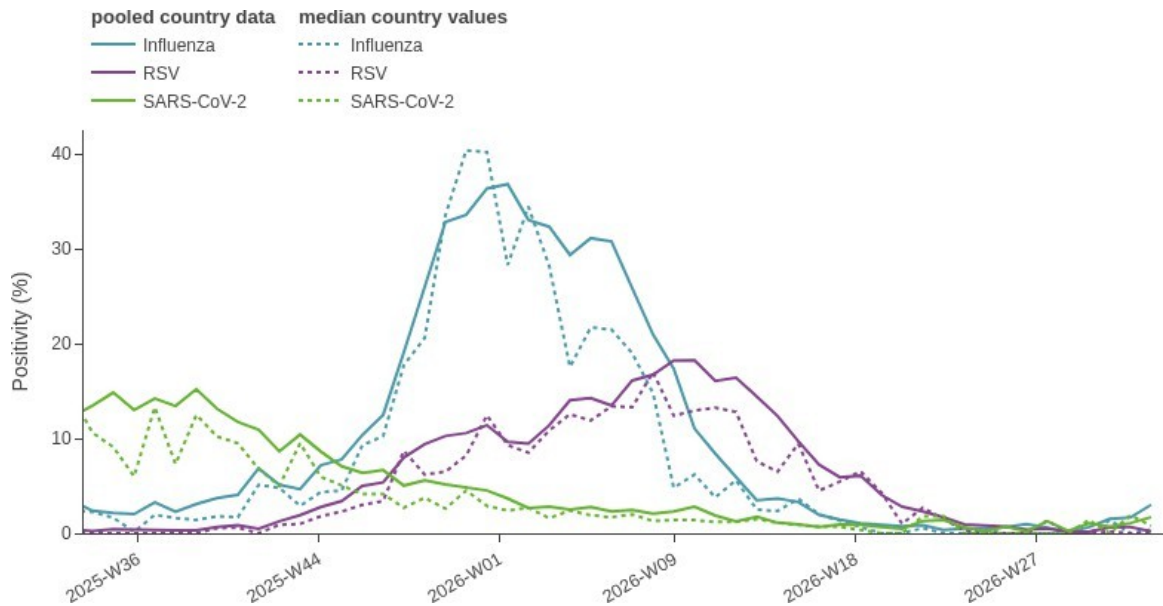
Ключові візуалізації з щотижневого бюлетеня наведено нижче.

Вірусологічний нагляд за ГПЗ/ГРЗ у первинній медичній допомозі
– щотижнева позитивність тесту.



UB
ДУ «Львівський ОЦКПХ МОЗ»
№36/709/26-30 від 18.08.2026
КЕП: ШЕВЧУК В. П. 18.08.2026 10:23
5E984D526F82F38F04000000356B801AB409F06

Вірусологічний нагляд за SARI у лікарнях – щотижнева позитивність тесту



Ключові показники

Indicator	Syndrome or pathogen	Reporting countries		EU/EEA summary	
		Week 32	Week 31	Description	Value
ILI/ARI consultation rates in primary care	ARI	13 rates (8 MEM)	13 rates (8 MEM)	Distribution of country MEM categories	8 Baseline
	ILI	14 rates (13 MEM)	14 rates (13 MEM)		13 Baseline
ILI/ARI test positivity in primary care	Influenza	11	12	Pooled (median; IQR)	3.3% (0; 0–3.9%)
	RSV	11	11		0% (0; 0–0%)
	SARS-CoV-2	11	12		5.2% (0; 0–0%)
SARI rates in hospitals	SARI	7 rates (4 MEM)	9 rates (5 MEM)	Distribution of country MEM categories	4 Baseline
SARI test positivity in hospitals	Influenza	6	7	Pooled (median; IQR)	3% (0.4; 0–2.1%)
	RSV	6	6		0.2% (0; 0–0%)
	SARS-CoV-2	7	7		1.7% (0.8; 0–2.5%)
Intensity (country-defined)	Influenza	7	9	Distribution of country qualitative categories	7 Baseline



**ГПЗ/ГРЗ вірусологічне спостереження впервинна медична
допомога – тип збудника та розподіл підтипів**

Pathogen	Week 32, 2026		Week 40, 2025 – week 32, 2026	
	N	% ^a	N	% ^a
Influenza	14	–	18011	–
Influenza A	14	100	17408	99
A(H1)pdm09	2	18	4066	28
A(H3)	9	82	10357	72
A (unknown)	3	–	2985	–
Influenza B	0	0.0	123	0.7
B/Vic	0	–	37	100
B (unknown)	0	–	86	–
Influenza untyped	0	–	480	–
RSV	0	–	5376	–
RSV-A	0	–	934	44
RSV-B	0	–	1192	56
RSV untyped	0	–	3250	–
SARS-CoV-2	22	–	4418	–

Вірусологічний нагляд за SARI у лікарнях–розподіл типу та підтипу патогена

Pathogen	Week 32, 2026		Week 40, 2025 – week 32, 2026	
	N	% ^a	N	% ^a
Influenza	16	–	15755	–
Influenza A	14	100	7630	99
A(H1)pdm09	0	–	1322	35
A(H3)	0	–	2426	65
A (unknown)	14	–	3882	–
Influenza B	0	0.0	73	0.9
B/Vic			10	100
B (unknown)	0	–	63	–
Influenza untyped	2	–	8052	–
RSV	1	–	7198	–
RSV-A			1152	52
RSV-B			1062	48
RSV untyped	1	–	4984	–
SARS-CoV-2	9	–	3064	–



Генетично охарактеризований розподіл вірусу грипу, 40-й тиждень 2025 року–тиждень 32, 2026

Subtype distribution			Subclade distribution		
Subtype	N	%	Subclade	N	%
A(H1)pdm09	3502	39	5a.2a.1(D.3.1)	3396	97
			5a.2a.1(D)	97	3
			5a.2a(C.1.9.3)	9	0.3
A(H3)	5442	60	2a.3a.1(K)	4825	89
			2a.3a.1(J.2)	320	6
			2a.3a.1(J.2.4)	240	4
			2a.3a.1(J.2.2)	31	0.6
			2a.3a.1(J)	25	0.5
			2a.3a.1(J.2.5)	1	0
B/Vic	106	1	V1A.3a.2(C.5.6)	38	36
			V1A.3a.2(C.5.1)	21	20
			V1A.3a.2(C.5.6.1)	20	19
			V1A.3a.2(C.3.1)	13	12
			V1A.3a.2(C.5.7)	12	11
			V1A.3a.2(C.5)	2	2

Поширення варіанту SARS-CoV-2, тиждень 43, 2025–тиждень 44, 2025

Variant	Classification ^a	Reporting countries	Detections	Distribution (median and IQR)
BA.2.86	VOI	0	0	0%
XFG	VUM	1	3	30% (30–30%)
BA.3.2	VUM	0	0	0%
NB.1.8.1	VUM	0	0	0%

Спалах хвороби Ебола, спричиненої вірусом Бундібудьйо – Демократична Республіка Конго та Уганда–2026 рік

Демократична Республіка Конго

13 серпня 2026 року Демократична Республіка Конго (ДРК) повідомила загалом про 4 665 підтверджених випадків, включаючи 2 184 пов'язані смерті (за даними станом на 12 серпня). Загалом 634 пацієнти госпіталізовані в ізоляції.



Це являє собою збільшення на 99 нових підтверджених випадків та 56 смертей з моменту публікації попереднього звіту від 12 серпня (за даними звітності станом на 11 серпня). Загалом 84,2% виявлених контактів з випадками перебувають під наглядом у постраждалих провінціях.

Загалом в країні зареєстровано 4 566 підтверджених випадків та 2 128 підтверджених смертей,

Станом на 13 серпня загалом уражено 54 зі 151 зони охорони здоров'я у шести провінціях. Найбільше постраждала провінція Ітурі, де зареєстровано 3912 випадків, включаючи 1702 летальні випадки, у 28 з 36 зон охорони здоров'я. У Північному Ківу зареєстровано 528 випадків, включаючи 369 смертей, у 12 з 34 зон охорони здоров'я. У Південному Ківу зареєстровано три випадки, включаючи один летальний випадок, в одній з 34 зон охорони здоров'я. У Верхньому Уеле зареєстровано 115 випадків, включаючи 51 летальний випадок, у 6 з 13 зон охорони здоров'я. У Тшопо зареєстровано дев'ять випадків захворювання, включаючи п'ять смертей, у 6 з 23 зон охорони здоров'я.

Уганда

Станом на 28 липня 2026 року загалом підтверджено 20 випадків, включаючи два летальні, повідомляє Міністерство охорони здоров'я Уганди. Останній підтверджений випадок було зареєстровано 21 червня, і з того часу нових випадків не зареєстровано. 16 липня Уганда виписала останнього пацієнта з Еболю, який отримував лікування в Національному ізоляційному центрі Мулагі. 28 липня 2026 року, через 12 днів після виписки останнього пацієнта, Міністерство охорони здоров'я Уганди оголосило про закінчення спалаху хвороби Ебола.

Інформація щодо ланцюгів передачі та уражених груп населення наразі обмежена, частково через складний контекст нестабільності та гуманітарних проблем у постраждалих районах. За даними ВООЗ, сусідні країни, що мають спільні сухопутні кордони з ДРК, вважаються такими, що мають високий ризик подальшого поширення хвороби через мобільність населення, торговельні та туристичні зв'язки, а також невизначеність щодо ланцюгів передачі. Спалах також може бути масштабнішим, ніж виявлено наразі. Існують також занепокоєння щодо цього спалаху, оскільки він спричинений вірусом Бундібуджйю, а не більш поширеним *Ортоеболавірус Заїренсе*. На відміну від *Ортоеболавірус Заїренсе*, наразі немає ліцензованих вакцин або специфічних методів лікування хвороби, спричиненої вірусом Бундібуджйю.

Враховуючи наявну інформацію, складний контекст та невизначеність щодо епідеміологічної інформації, ВООЗ оголосила надзвичайну ситуацію у сфері охорони здоров'я, що має міжнародне значення 17 травня 2026 року.

Це 17-й спалах хвороби Ебола, зареєстрований у ДРК. Останній спалах стався у 2025 році в провінції Касаї через вірус Ебола *Ортоеболавірус Заїренсе* (ВООЗ

Обмеження на поїздки

Влада кількох країн запровадила посилені протоколи контролю та скринінгу для обмеження ризику поширення вірусу.

Перевірку на виїзді було запроваджено в ДРК, Уганді та Південному Судані. Пункти в'їзду (РоЕ) та пункти контролю (РоС) були активовані в ключових місцях, включаючи аеропорти, дорожні контрольно-пропускні пункти та міста або місцеві транзитні пункти, такі як Нізі та Іруму (Ітурі), Мудзібала (Бунія), Деле і Чай (Рвампара). Аеропорт Бунія в провінції Ітурі був тимчасово закритий 23 травня і знову відкритий 2 червня із запровадженням заходів медичного обстеження.



Комерційні рейси до та з аеропорту Бунія тимчасово були заборонені з 6 червня, в рамках заходів щодо безпеки здоров'я у відповідь на спалах хвороби Ебола.

Міністерство охорони здоров'я Уганди оголосило 15 червня 2026 року, що громадськість, мандрівники, агентства з працевлаштування, туристичні агенти та всі зацікавлені сторони, які виїжджають з Уганди, не потребують «Сертифіката про відсутність вірусу Ебола». «Сертифікат про відсутність вірусу Ебола» не є обов'язковою вимогою для подання заяв на отримання візи до будь-якої країни.

Тестування на вірус Ебола рекомендується для осіб із симптомами, що відповідають захворюванню, спричиненому вірусом Ебола, або тих, хто ідентифікований як контактні особи з підтвердженими випадками захворювання, спричиненого вірусом Ебола, на основі клінічної та епідеміологічної оцінки, проведеної органами охорони здоров'я. Міністерство охорони здоров'я Руанди посилило медичний огляд та пильність у наземних пунктах в'їзду вздовж кордону з ДРК. У міжнародному аеропорту Кігалі для мандрівників, які в'їжджають до Руанди, було запроваджено посилені заходи контролю на в'їзді.

Ряд країн також запровадили обмеження на в'їзд та медичне обстеження для осіб, які подорожують з країн високого ризику, зокрема США, Канада, Туніс, Таїланд, Маврикій і Багамські острови.

24 червня, в рамках реагування на триваючий спалах, Міністерство охорони здоров'я ДРК видало постанову щодо забезпечення виконання таких заходів: контакти підтверджених або ймовірних випадків перебувають 21 день під активним самомоніторингом та обмеженнями як на пересування всередині країни, так і за кордон. Медичні працівники та працівники служб реагування, які повертаються з уражених районів, підпадають під аналогічні правила, хоча активний моніторинг прямо не зазначений, а поїздки всередині країни залишаються дозволеними. Будь-хто, хто перебував у ураженій провінції, не може подорожувати за кордон протягом 21 дня (це не стосується жодних зобов'язань щодо фактичних випадків). Крім того, міжнародні мандрівники, які виїжджають за кордон, повинні заповнити обов'язкову форму декларації про стан здоров'я, видану прикордонними органами охорони здоров'я.

Терапевтичні засоби та вакцини

Оксфордська група вакцин Оксфордського університету успішно вакцинувала першого добровольця в рамках першого у світі випробування вакцини проти вірусу ебола Бундібуджйо. Вакцину розробили вчені з Оксфордської групи вакцин та Інституту пандемічних наук Оксфордського університету.

Оцінка ЄЦПКЗ:

З огляду на прогалини в епідеміологічній інформації та обмежене спостереження за контактами, ймовірно, що спалах є більш масштабним, ніж повідомляється наразі, з точки зору кількості уражених випадків/ районів. Враховуючи всю наявну інформацію та невизначеності щодо цього спалаху, ймовірність зараження для людей з ЄС/ЄЕЗ, які проживають у уражених районах або подорожують до них, оцінюється як низька.

Враховуючи дуже низьку ймовірність завезення та вторинної передачі, ймовірність зараження для людей, які проживають у ЄС/ЄЕЗ, оцінюється як дуже низька. Загальний ризик передачі вірусу Бундібуджйо через речовини людського походження (SoHo) в ЄС/ЄЕЗ наразі оцінюється як дуже низький.

Виїзний скринінг у уражених країнах, включаючи перевірку симптомів та оцінку впливу, є важливим, оскільки він сприяє зниженню ризику шляхом виявлення мандрівників із симптомами до посадки на рейс, щоб запобігти їхній подорожі під час прояву симптомів. Виїзний скринінг також допомагає відмовити

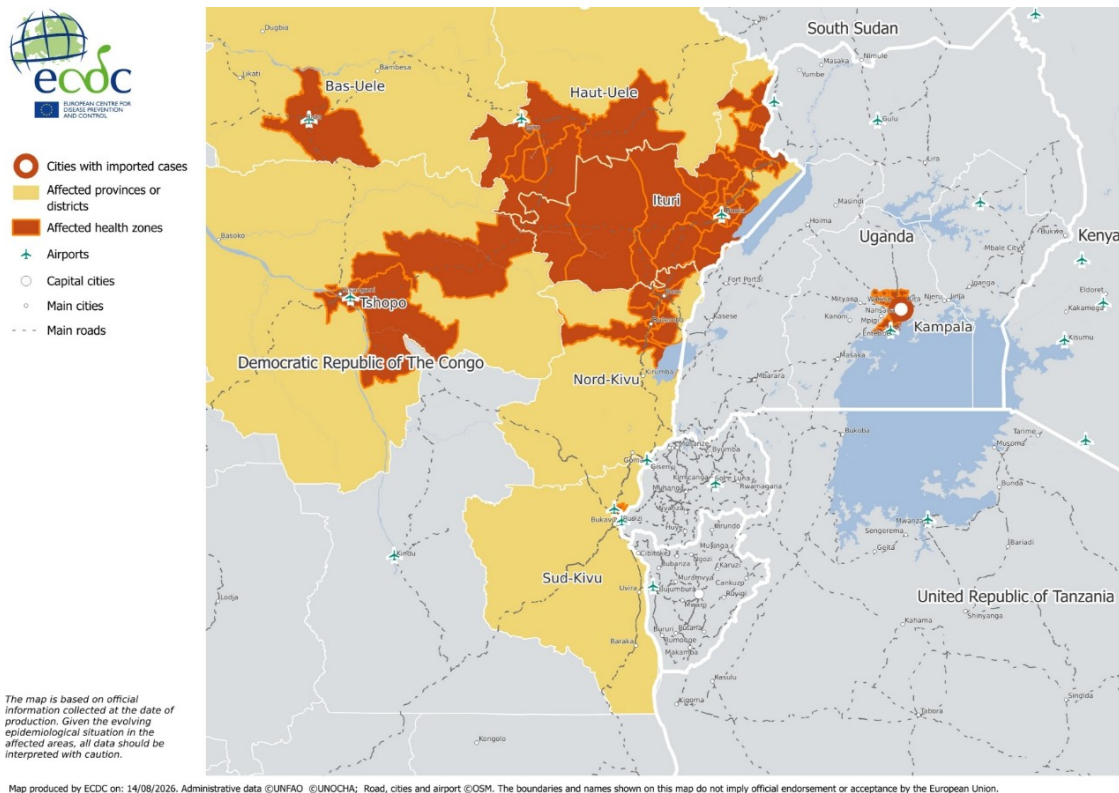


людей із симптомами від подорожей та підвищує довіру громадськості та зацікавлених сторін. Однак він не може повністю запобігти експорту випадків, оскільки відсутність симптомів під час відправлення не виключає подальшого виникнення захворювання.

ЄЦПКЗ вважає, що скринінг мандрівників, які повертаються з уражених районів (ДРК, Уганда), не буде ефективним у запобіганні потраплянню вірусу до Європи.

Це міркування ґрунтується на отриманих уроках та результатах великого спалаху вірусу Евені у Західній Африці між 2013 і 2016 роками, коли було зареєстровано десятки тисяч випадків, передача вірусу тривала у великих міських центрах. Скринінг мандрівників, що в'їжджають, потребує багато часу та ресурсів і не дозволить ефективно виявити людей з інфекцією. Натомість пріоритет слід надати наданню мандрівникам чіткої інформації про симптоми, шляхи передачі та що робити, якщо симптоми з'являться після прибуття до ЄС/ЄЕЗ.

Карта уражених районів спалаху хвороби Ебола, спричиненої вірусом Бундібуджьо, Демократична Республіка Конго та Уганда, 2026 рік



Джерело: ЄЦПКЗ

Розгортання експертів

З 19 травня 2026 року Робоча група ЄС з питань охорони здоров'я (EUNTF), що підтримує зусилля з підготовки та реагування, пов'язані зі спалахом хвороби Ебола, спричиненої вірусом Бундібуджьо, працює у Демократичній Республіці Конго (ДРК) та Уганді.

Вісім експертів ECDC були направлені на ротаційній основі для підтримки Центрів контролю та профілактики захворювань Африки, спочатку в штаб-квартирі в Аддис-Абебі, а з 23 червня 2026 року — до складу Континентальної групи підтримки управління інцидентами (IMST) в Уганді. Розгортання є частиною проекту «...Безпека здоров'я та «Єдине здоров'я» в Африці – Африканський центр контролю та профілактики захворювань у партнерстві з ECDC та Європейським агентством з безпеки харчових продуктів (ФАЗА II), фінансується Генеральним директором Європейської Комісії з питань міжнародного партнерства. Експерти надавали підтримку у проведенні заходів спостереження та зв'язку. У період з 15 по 22 червня 2026 року EUNTF направила команду з трьох експертів ECDC та двох експертів держав-членів до Кіншаси (ДРК) та Кампали (Уганда) для проведення місії з встановлення фактів у пункті в'їзду з метою оцінки впровадження та операційної ефективності процедур перевірки на виїзді.

Між 16 червня та 8 липня 2026 року експерта ECDC з питань комунікації ризиків та залучення громади (RCCE) було направлено до представництва Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) у Джубі, Південний Судан, у відповідь на запит про допомогу від Глобальної мережі оповіщення та реагування на спалахи (GOARN). Експерт підтримував реалізацію польового плану RCCE в країні щодо посилення залучення громади та вирішення пріоритетних питань комунікації іск та залучення громади прогалини у зонах високого ризику. З 14 липня двох стипендіатів ECDC також було направлено через GOARN до офісу ВООЗ у Джубі, Південний Судан, для підтримки діяльності з епіднагляду та аналізу даних.

Ці заходи проводяться у тісній координації з національними органами влади та делегаціями ЄС, а також у співпраці з Генеральним директором з питань цивільного захисту та гуманітарної допомоги в Європі та Генеральним директором з питань міжнародного партнерства.

Сезонний моніторинг навколишнього середовища для ризику зараження вібріонами (*Vibrio spp.*) у прибережних водах – Купальний сезон 2026

На основі прогнозів протягом наступних п'яти днів (до 19 серпня 2026 року) в 41 муніципалітеті у дев'яти регіонах чотирьох країн очікується висока екологічна придатність для *Вібріонів*. Найбільша кількість муніципалітетів, що перевищують поріг, виявлена у Франції (14), Болгарії (13) та Румунії (12).

Список районів, що очікуються висока екологічна придатність для *Вібріон* spp. до 19 серпня 2026 року наведено нижче.

Болгарія: 13 муніципалітетів у трьох регіонах:

- Варна: Аврен, Бяла, Дольні чифлик, Варна
- Добрич: Балчик, Каварна, Шабла
- Бургас: шість муніципалітетів перевищують

поріг Франція: 14 муніципалітетів у трьох регіонах:

- Жиронда: Вісім муніципалітетів перевищують поріг
- Приморська Шаранта: Chenac-Saint-Seuren-d'Uzet, Le Château-d'Oléron, Le Verdon-sur-Mer, Royan, Talmont-sur-Gironde

- Буш-дю-Рон Арль Італія: два муніципалітети в одному регіоні:

- Горіція Градо, Старанцано Румунія: 12 муніципалітетів у двох регіонах:
- Константа: Вісім муніципалітетів перевищують поріг
- Тулча: Юриловка, Мурігіул, Орас Суліна, Сфанту Георге



Країни перелічені в алфавітному порядку; муніципалітети перелічені лише для регіонів (на рівні NUTS3) з п'ятьма або менше постраждалими муніципалітетами.

* Примітка: висока екологічна придатність для *Vibrio* spp. визначається індексом придатності >16.

Передісторія

Вібріоз – це інфекція, що викликається видами *Vibrio*-бактерії, які зустрічаються природним чином у прибережних водах, особливо в теплих, солонуватих середовищах, де змішуються прісна та морська вода. Умови навколишнього середовища, що сприяють росту бактерій, включають вищі температури води та нижчу солоність. У Європі, *Vibrio*-бактерії найчастіше виявляються протягом літнього сезону.

Балтійське море забезпечує особливо сприятливі умови завдяки відносно низькій солоності, хоча *Vibrio*-види також зустрічаються у Північному морі, Чорному морі та інших прибережних та естуарних водоймах для купання.

Зараження людини може статися через вживання сирих або недостатньо термічно оброблених морепродуктів, зокрема моллюсків, або через контакт відкритих ран із забрудненою водою. Клінічні прояви варіюються від самообмежувального гастроентериту до ранових інфекцій, отиту та тяжких інвазивних захворювань, включаючи сепсис та некротичні інфекції м'яких тканин. Особи з супутніми захворюваннями, такими як діабет, хронічні захворювання печінки та імуносупресія, мають підвищений ризик тяжкого перебігу захворювання.

Оцінка ЄЦПКЗ:

Очікується, що потепління, зумовлене кліматом, збільшить придатність прибережних районів для росту бактерій. Оскільки температура поверхні моря продовжує зростати в деяких частинах Європи, умови навколишнього середовища, що сприяють потенційному *Vibrio*-поширенню та географічна експансія стають дедалі поширенішими.

Вібріоз залишається відносно рідкісним явищем у ЄС/ЄЕЗ. Однак, місцеві випадки можуть траплятися протягом літніх місяців, особливо коли температура надзвичайно висока.

Щоб зменшити ризик хвороби у разі потрапляння інфекцій через їжу рекомендується ретельно протермічно обробляти морепродукти перед вживанням. Людям з відкритими ранами, нещодавніми пірсингами, порізами або подряпинами слід уникати купання в солонуватих або прибережних водах або накривати уражену ділянку водонепроникною пов'язкою. У разі випадкового контакту з прибережною водою уражену ділянку слід продезінфікувати та ретельно очистити.

Всесвітнього фестивалю гордості – Нідерланди, 2026 рік

Від початку періоду моніторингу 20 липня і станом на 14 серпня жодних серйозних подій у сфері громадського здоров'я, пов'язаних з інфекційними захворюваннями, в контексті Всесвітнього фестивалю гордості 2026 року не було виявлено.

Короткий зміст

Всесвітній прайд 2026 відбувся в Амстердамі, Нідерланди, з 25 липня по 8 серпня 2026 року. Захід зібрав велику кількість учасників, включаючи іноземних гостей з усього ЄС/ЄЕЗ та інших регіонів світу. Заходи включали культурні та мистецькі виступи, а також масштабні громадські заходи, кульмінацією яких став публічний парад 8 серпня в центрі Амстердама. Захід проходив на кількох критих та відкритих майданчиках, деякі з яких мали високу щільність натовпу та тривалий контакт між учасниками.



Передісторія

В останні роки зросли показники захворюваності на ІПСШ, такі як гонорея та сифіліс продовжував зростати серед геїв, бісексуалів та інших чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками, в ЄС/ЄЕЗ. Крім того, серед цієї групи населення повідомлялося про кластери та спалахи інших інфекцій, які можуть передаватися через інтимний контакт, включаючи трох, дерматофіліоз, вірусний гепатит та лікарсько-резистентний Шигелльоз.

Місцеві та регіональні органи охорони здоров'я в Амстердамі посилили можливості раннього виявлення, епідеміологічного спостереження, діагностики, відбору проб та секвенування, а також профілактичних заходів для населення, яке найбільше ризикує, та в місцях, де може статися зараження.

Спираючись на ці заходи щодо готовності, ECDC рекомендує органам охорони здоров'я співпрацювати з організаціями громадянського суспільства та іншими партнерами, щоб забезпечити геям, бісексуалам та іншим чоловікам, які мають секс з чоловіками, доступ до точної інформації та послуг. Учасникам заходів World Pride рекомендується пам'ятати про наступне:

- Забезпечте актуальність планової вакцинації та ревакцинації відповідно до національних рекомендацій щодо імунізації в країні проживання, включаючи вакцинацію проти гепатиту А. Учасникам рекомендується обговорити необхідність додаткових вакцинацій, таких як мпоксин або ревакцинація, зі своїми медичними працівниками.

- Забезпечте покриття дійсним медичним страхуванням або отримайте Європейську картку медичного страхування.

- Перед відвідуванням заходу ознайомитися з профілактикою ІПСШ, включаючи рекомендації щодо доконтактної профілактики ВІЛ, а також ознайомитися з додатковими порадами та інформацією на вебсайті заходу.

- Зверніться до медичного працівника у своїй країні, щоб обговорити інші запобіжні заходи на основі оцінки ризику для сексуального здоров'я; він може рекомендувати доконтактну профілактику (ДКП) ВІЛ, але пам'ятайте, що ДКП не захищає від інших ІПСШ.

- Практикуйте безпечніший секс, використовуючи презервативи, щоб запобігти зараженню ІПСШ, включаючи ВІЛ та гепатити В і С.

- Хоча використання презерватива є важливим захисним заходом, він не забезпечує повного захисту від мпокс-інфекції, оскільки мпокс може передаватися через тісний контакт шкіри до шкіри, особливо якщо на шкірі є висипання, ранки або ураження. Це також стосується дерматофіліозу.

- Уникайте статевих актів та звертайтеся за медичною допомогою у разі виникнення симптомів ІПСШ, включаючи шлунково-кишкові симптоми або симптоми, що свідчать про мпоксофіліоз чи дерматофіліоз, у себе або будь-якого сексуального партнера.

- Уникайте фекально-орального контакту під час статевого акту, щоб запобігти іншим інфекціям, таким як шигелльоз та гепатит А (тобто мийте руки, статеві органи та анальний канал до та після статевого контакту, завжди використовуйте презерватив, змінюйте презервативи між анальним та оральним сексом, використовуйте рукавички або презервативи на секс-іграшках, використовуйте дентальні капи для орального сексу та латексні рукавички для фінгерінгу або фістінгу). Якщо з'являються шлунково-кишкові симптоми, повідомте медичних працівників про статевий акт та утримуйтеся від сексу, доки симптоми не зникнуть.



- Дотримуйтесь стандартних гігієнічних заходів та порад щодо профілактики захворювань, що передаються через харчові продукти та воду, щоб зменшити ризик шлунково-кишкових захворювань, а також враховуйте загальні гігієнічні/безпечні методи харчування під час вживання їжі та напоїв.

- У разі контакту з ВІЛ, гепатитом А або В або інфекцією МРОХ учасникам слід якомога швидше звернутися до медичного працівника за консультацією, оскільки для деяких інфекцій доступна постконтактна профілактика (ПКП) у формі вакцинації або таблеток, і її слід розпочати якомога швидше (протягом 72 годин для ВІЛ).

Якщо у учасників виникають симптоми, що свідчать про інфекцію, їм слід звернутися до медичного працівника під час заходу. Люди з ІПСШ можуть не мати жодних симптомів, але поширені симптоми включають: незвичайні виділення зі статевих органів або прямої кишки, свербіж, біль під час сечовипускання, біль у прямій кишці, зміни шкіри (включаючи висип або пухиреподібні ураження), пожовтіння шкіри, біль під час сексу та грипоподібні симптоми. Якщо у учасників є будь-який із цих симптомів або сильна діарея (яка може бути спричинена шигелозом або гепатитом А), їм слід уникати статевих актів та негайно звернутися за медичною допомогою.

- Загалом, якщо вони мали незахищений статевий акт з випадковим партнером, їм слід звернутися до медичного працівника за порадою щодо тестування на ІПСШ, включаючи млакоксифен, ВІЛ та гепатит, оскільки ІПСШ можуть проявлятися без будь-яких симптомів.

Люди, які відвідують World Pride та заразилися інфекцією, можуть сприяти подальшій передачі інфекцій у межах статевих мереж у своїх країнах. Країни ЄС/ЄЕЗ повинні розглянути питання про підвищення обізнаності серед клініцистів та лабораторних працівників, а також підготуватися до забезпечення постконтактної профілактики (де показано), тестування, лікування та ведення партнерів у виявлених випадках.

Сезонний нагляд за хворобою, спричиненою вірусом чикунгунья – 2026

Від початку 2026 року та станом на 12 серпня 2026 року лише у Франції було зареєстровано місцеві випадки (15 випадків) захворювання, спричиненого вірусом чикунгунья, в Європі.

Минулого тижня у Франції було зареєстровано вісім нових випадків місцевого зараження вірусом чикунгунья. Наразі існує два активні кластери.

Дії:

ECDC продовжуватиме стежити за ситуацією та публікуватиме щотижневий звіт про випадки захворювання, спричиненого вірусом чикунгунья, в ЄС/ЄЕЗ до листопада 2026 року.

Додаткова інформація:

Чикунгунья – це вірусне захворювання, що передається комарами, яке з'являється в Європі, причому випадки місцевого поширення зареєстровані в кількох країнах ЄС/ЄЕЗ. У світлі цього розвитку подій ECDC запровадив посилений сезонний нагляд для моніторингу виникнення випадків захворювання в ЄС/ЄЕЗ. Головною метою є інформування органів охорони здоров'я та підтримка впровадження відповідних заходів реагування.

Сезонний нагляд за денге в ЄС/ЄЕЗ

Від початку 2026 року та станом на 12 серпня 2026 року одна країна Європи повідомила про випадки денге, придбані на місцевому рівні: Франція (один випадок).



Цього тижня до ECDC не надходило зареєстрованих нових випадків лихоманки денге.

Дії:

ECDC продовжуватиме стежити за ситуацією та публікуватиме щотижневий звіт про поширеність лихоманки денге в ЄС/ЄЕЗ до листопада 2026 року.

Додаткова інформація:

Денге – це вірусне захворювання, що передається комарами, яке дедалі частіше зустрічається в Європі, причому випадки місцевого поширення зареєстровані в кількох країнах ЄС/ЄЕЗ. У світлі цього розвитку подій ECDC запровадив сезонний посилений щотижневий нагляд для моніторингу виникнення випадків захворювання в ЄС/ЄЕЗ.

Головною метою є інформування органів охорони здоров'я та підтримка впровадження відповідних заходів реагування. Це включає оцінку ризику передачі денге через речовини людського походження (SoHO).

Сезонний нагляд за інфекціями вірусу Західного Нілу– 2026

Інфекція ВЗН у людей є захворюванням, про яке необхідно повідомляти на рівні ЄС, і про випадки захворювання національні органи охорони здоров'я повинні повідомляти через платформу EpiPulse.

Оцінка ЄЦПКЗ:

Сезонні погодні умови наразі сприяють передачі вірусу через комарів; тому очікується, що найближчими тижнями зросте кількість випадків.

У 2026 році, станом на 5 серпня, сім країн Європи повідомили про 245 випадків, придбаних на місцевому рівні.

[Про випадки місцевого придбання повідомляли Італія (139 випадків), Греція (65, з яких чотири з невідомим місцем зараження), Іспанія (17 випадків), Північна Македонія (13 випадків), Румунія (шість випадків), Франція (чотири випадки) та Німеччина (один випадок). У Європі було зареєстровано 12 смертей – Греція (шість смертей), Італія (п'ять смертей) та Румунія (одна смерть).

Кількість зареєстрованих випадків захворювання людей (245 випадків) нижчий за середній показник за відповідний період останнього десятиліття (403 випадки). Однак, затримки зі звітністю можуть призвести до недооцінки поточного тягаря.

Цього року вперше в історії було зареєстровано випадки зараження людей вірусом Західного Нілу в місцевому масштабі: Франція у Східних Піренеях; Німеччина у Рейн-Пфальц-Крайсі; Італія у Кампобассо (ITF22) і Вітербо; і Північна Македонія у Пелагоніскі і Вардарскі.

Як і в попередні роки, більшість випадків було зареєстровано у чоловіків віком 65 років і старше. Більшість випадків були госпіталізовані (72%) з неврологічними симптомами (58%). Частка госпіталізованих була нижчою за середній показник, зареєстрований за попереднє десятиліття (87%), а частка з неврологічними симптомами також була дещо нижчою за середній показник за історичні 10 років (64%). Рівень летальності становив приблизно 5%, що нижче за середній показник, зареєстрований за попереднє десятиліття (11%). Однак цю оцінку слід інтерпретувати з обережністю, оскільки клінічні результати можуть бути ще не відомі для всіх зареєстрованих випадків, а додаткові смерті можуть бути зареєстровані в міру проходження сезону та консолідації даних.

Результати ветеринарного нагляду

З ветеринарної точки зору, у 2026 році в Європі було зареєстровано 17 спалахів вірусу Західного Нілу серед коней та 74 спалахи серед птахів. Найдавніша дата початку спалаху серед коней та птахів була 30 березня 2026 року у Франції та



31 березня 2026 року в Італії, тоді як останній початок спалаху серед коней та птахів стався 31 липня 2026 року в Нідерландах та 28 липня 2026 року в Італії. Про спалахи серед коней повідомляли Франція (п'ять спалахів), Греція (п'ять спалахів), Італія (п'ять спалахів), Нідерланди (один спалах) та Іспанія (один спалах).

Про спалахи серед птахів повідомляли Італія (64 спалахи), Франція (п'ять спалахів), Іспанія (три спалахи), Австрія (один спалах) та Бельгія (один спалах).

Закономірності в епіднагляді за людьми та ветеринарією

Чотири країни – Франція, Греція, Італія і Іспанія – повідомлялося як про випадки зараження вірусом Західного Нілу у людей, так і про спалахи серед конячих та/або птахів. Станом на 5 серпня Італія інформує про більшість зареєстрованих випадків захворювання людей (56,7%) та спалахів захворювання тварин (75,8%). Греція зареєструвала другу за величиною частку випадків захворювання людей (26,5%), але лише п'ять спалахів серед коней та жодного спалаху серед птахів, що становить 5,5% від усіх зареєстрованих спалахів серед тварин.

Відмінності у закономірностях, що спостерігаються в різних європейських країнах, можуть відображати поєднання екологічних, кліматичних та пов'язаних зі спостереженням факторів.

Сприятливі кліматичні умови та наявність екологічних гарячих точок, таких як водно-болотні угіддя та сільськогосподарські угіддя, можуть підтримувати популяції комарів-переносників та впливати на розподіл і поведінку тварин-господарів, тим самим сприяючи циркуляції вірусу Західного Нілу. Водночас відмінності в системах спостереження за вірусом Західного Нілу в Європі можуть впливати на рівень виявлення та звітності.

У Франції (Східні Піренеї, FRJ15), Греції (Драма, EL514), та Італії (Генуя, ITS33), випадки захворювання людей були зареєстровані до або за відсутності зареєстрованих спалахів у птахів або конячих. І навпаки, у Бельгії (Арр. Намюр, BE352), Франції (О-де-Сен, Сена і Марна), і Нідерландах (Делфт-ен-Вестленд), виявлення випадків захворювання у тварин передувало випадкам захворювання у людей.

Бельгія є релевантним прикладом, оскільки вірус Західного Нілу вперше був зареєстрований у країні у 2025 році під час спостереження за птахами, без попередніх виявлень у людей чи тварин. У 2026 році його знову було виявлено у птахів у раніше не ураженому регіоні, що підкреслює роль спостереження за птахами у виявленні локальної циркуляції вірусу та географічного поширення.

Оцінка ЄЦПКЗ:

З огляду на сприятливі погодні умови для передачі вірусу Західного Нілу в Європі, ECDC та EFSA очікують, що найближчими тижнями буде зареєстровано подальші випадки захворювання людей та спалахи серед конячих та птахів. У попередні роки пік передачі зазвичай припадав на серпень та вересень.

Дії:

ECDC здійснює моніторинг інфекцій, викликаних вірусом Західного Нілу, за допомогою заходів спостереження на основі індикаторів та подій.

Сезонний нагляд за кримсько-конголезькою геморагічною лихоманкою – 2026

Від початку 2026 року і станом на 12 серпня 2026 року в Іспанії було зареєстровано місцеві випадки (три випадки) кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ) у Європі. За останній тиждень до ECDC не надійшло жодного нового випадку ККГЛ.



Оцінка ЄЦПКЗ:

Хоча ризик зараження ККГЛ для населення в районах Іспанії, де відомо про наявність вірусу, є низьким, цей ризик зростає для людей, які займаються активним відпочинком на свіжому повітрі, що призводить до укусів кліщів (наприклад, полювання, лісогосподарська робота, піші прогулянки, спостереження за тваринами). Як загальний запобіжний захід проти ККГЛ, а також проти інших захворювань, що передаються кліщами, люди, які потенційно можуть бути піддані впливу кліщів, повинні застосовувати засоби індивідуального захисту.

В Іспанії вірус ККГЛ передається людині переважно кліщами роду *Гіаломма*. Поки *Гіаломма лузітанікум* відіграє ключову роль у підтримці та динаміці передачі вірусу. *Кліщ* широкоприсутній у південній та східній Європі і у деяких частинах південної Європи. Албанські органи охорони здоров'я повідомили про випадок кримсько-конголезької геморагічної лихоманки (ККГЛ) у районі Тропоє на півночі країни.

Пацієнт займається тваринництвом та має домашніх тварин. Дата початку захворювання – 22 липня 2026 року, пацієнт був госпіталізований 24 липня 2026 року. Згодом пацієнт одужав та був виписаний з лікарні.

Зразки з цього випадку виявили позитивний результат як на РНК вірусу ККГЛ за допомогою ПЛР у реальному часі, так і на специфічні до ККГЛ антитіла за допомогою серологічного тесту. Діагноз було підтверджено 4 серпня 2026 року. Ентомологічні дослідження тривають.

Оцінка ЄЦПКЗ:

Випадок було зареєстровано в регіоні, який раніше не був визнаний ендемічним щодо ККГЛ в Албанії. Однак випадки ККГЛ були зареєстровані в тому ж повіті (Кукес); останній у 2023 році. Вид кліщів *Гіаломма маргінатум*, який є основним переносником вірусу ККГЛ, був виявлено майже у всіх регіонах країни.

Ймовірність зараження для громадян ЄС/ЄЕЗ, які подорожують до Албанії або проживають там, дуже низька. Однак, враховуючи потенційно тяжкий або смертельний результат захворювання, слід застосовувати заходи індивідуального захисту від укусів кліщів, видаляти кліщів, що заражають організм, а у разі появи клінічних симптомів, що викликають лихоманку, пацієнтам слід звернутися за медичною допомогою. Лікарів загальної практики слід поінформувати про історію попередніх подорожей та укусів кліщів пацієнта.

Мрох (віспа мавп) у ЄС/ЄЕЗ, на Західних Балканах та в Туреччині – 2026 рік

Оновлення за липень 2026 року

У липні 2026 року 12 країн зареєстровано 153 випадки захворювання на мрак (трох), спричиненого вірусом МРХV класу I, причому найбільшу кількість випадків було зареєстровано в Португалії (68).

У липні 2026 року п'ять країн зареєстровано 12 випадків трох clade II, причому найбільшу кількість випадків зареєстровано у Франції (7).

Огляд за останні 12 місяців (серпень 2025 – липень 2026)

За останні 12 місяців 20 країн повідомили про 1083 випадки трох класу I, а 19 країн – про 888 випадків трох класу II.

Серед випадків з повною інформацією:

- Загалом, 89% випадків трох класу I та 91% випадків трох класу II було зареєстровано серед чоловіків, які мають секс з чоловіками.

- Загалом, 12% випадків трох класу I та 8% випадків трох класу II було госпіталізовано. Серед людей, інфікованих МРХV класу II, було зареєстровано два смертельні випадки; серед людей, інфікованих МРХV класу I, смертельних випадків не зареєстровано.



• Загалом 22% випадків трох кладу I та 20% випадків трох кладу II з відомим статусом вакцинації отримали дві дози вакцини.

Після зростання, що спостерігалось наприкінці 2025 та на початку 2026 років, кількість зареєстрованих випадків трох кладу I в ЄС/ЄЕЗ залишається відносно стабільною, тоді як кількість зареєстрованих випадків трох кладу II продовжує знижуватися.

Однак інтерпретація тенденцій обмежена через відсутність інформації про кладу для значної частини зареєстрованих випадків, а інформація про випадки та епідеміологічна інформація може оновлюватися ретроспективно.

Згідно з інформацією, наданою державами-членами, клінічна картина загалом легка, зокрема серед госпіталізованих випадків.

Переважну більшість зареєстрованих випадків трох становлять кладу Ib та IIb. Серед випадків з відомою кладою з початку спостереження у 2022 році в ЄС/ЄЕЗ було зареєстровано лише один випадок кладу Ia та три випадки кладу IIa.

Оцінка ЄЦПКЗ:

Випадки трох як кладу I, так і кладу II продовжують реєструватися в ЄС/ЄЕЗ, із загалом легкою клінічною картиною.

Хоча ранні випадки кладу I були переважно імпортовані з-за меж ЄС/ЄЕЗ та зареєстровані серед гетеросексуальних осіб та їхніх близьких контактів, зараз більшість випадків зареєстровано серед чоловіків, які мають секс з чоловіками. Передача в цих мережах спостерігається для обох клад і відбувається переважно серед невакцинованих осіб.

Зі збільшенням кількості подорожей протягом літа та відвідуванням масових зібрань, таких як прайд-акції, існує ризик подальшого поширення трох як кладу I, так і кладу II.

Країнам ЄС/ЄЕЗ рекомендується збільшення охоплення вакцинацією, особливо серед груп населення з підвищеним ризиком зараження, включаючи чоловіків, які мають статеві стосунки з чоловіками. Збільшення охоплення вакцинацією залишається найважливішим заходом для пом'якшення поширення обох клад, особливо протягом весняного та літнього сезонів. Зміцнення здоров'я та залучення громадитакож є критично важливими для забезпечення ефективної інформаційно-просвітницької роботи та високого рівня схвалення та охоплення вакцинацією серед тих, хто найбільше ризикує зараження.

Стратегії первинної профілактичної вакцинації (ППВ) та постконтактної профілактичної вакцинації (ПЕПВ) можуть бути поєднані для охоплення осіб із значно вищим ризиком зараження та тісними контактами хворих відповідно, особливо у разі обмежених запасів вакцини. Стратегії ППВ повинні надавати пріоритет геям, бісексуалам та трансгендерним особам, а також чоловікам, які мають секс з чоловіками, які мають вищий ризик зараження.

Стратегії також повинні надавати пріоритет особам, які мають ризик професійного зараження, на основі епідеміологічних або поведінкових критеріїв.

Додаткові варіанти реагування для країн ЄС/ЄЕЗ включають:

- підвищення обізнаності серед медичних працівників;
- підтримка служб сексуального здоров'я у виявленні випадків, відстеженні контактів та веденні справ;
- забезпечення легкодоступності тестування.



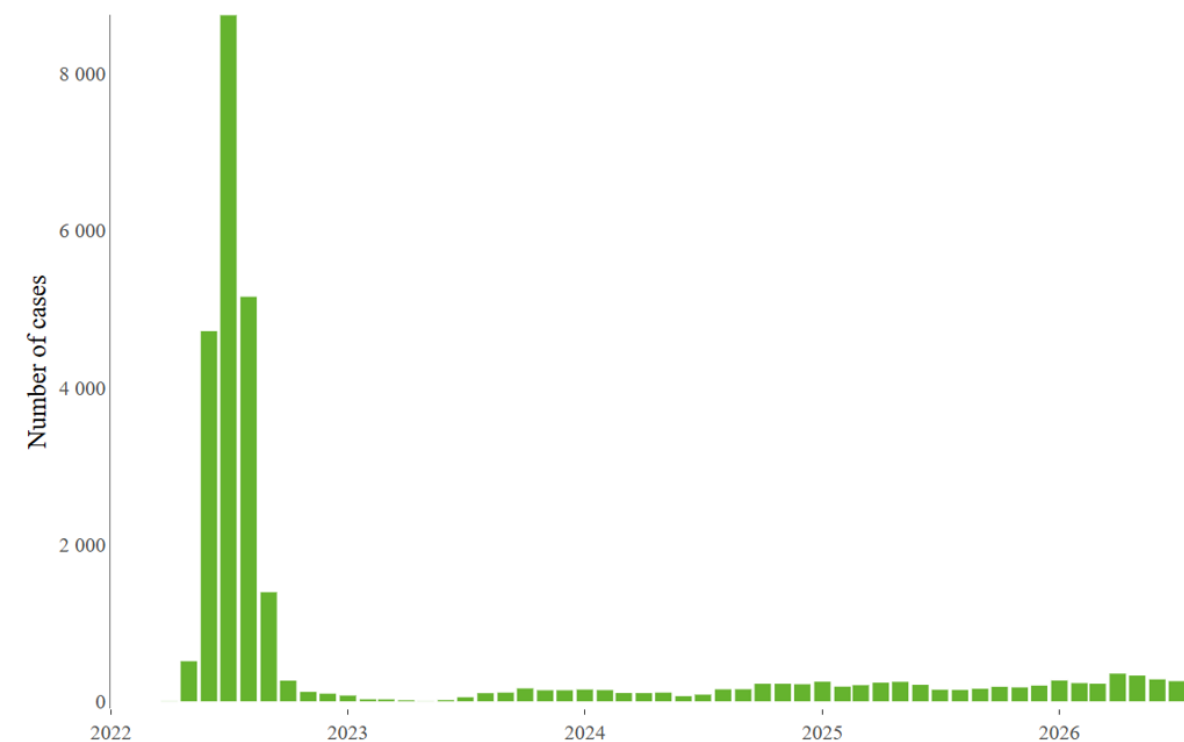
Карти та графіки:

**Випадки Мрох за кладами за останні 12 місяців
(серпень 2025 р. – липень 2026 р.) та минулий місяць (липень 2026 р.),
ЄС/ЄЕЗ**

Country	Clade I		Clade II		Clade Unknown	
	Past 12 months	Past month	Past 12 months	Past month	Past 12 months	Past month
Austria	14	1	10			
Belgium	43		8		131	4
Croatia					2	
Czechia	7		2			
Denmark	8	1	1			
Finland					1	
France	170	19	60	7	84	19
Germany	151	26	147	2	155	11
Greece	8		1		1	
Hungary	1	1	2			
Iceland					1	
Ireland	25	11	24		1	1
Italy	79	5	8	1	81	4
Lithuania	1				1	
Luxembourg	3		4			
Malta			3			
Netherlands	54	10	68	1	11	5
Norway	1		9			
Poland	3	1	2		16	1
Portugal	172	68	63		64	
Romania	2					
Slovakia	4				1	
Slovenia			1			
Spain	303	7	468	1	285	43
Sweden	34	3	7		7	4
EU/EEA total	1 083	153	888	12	842	92

Джерело: ЄЦПКЗ

**Загальна кількість випадків трох (усі класи)
з січня 2022 року та станом на 11 серпня, ЄС/ЄЗ**



Джерело: ЄЦПКЗ

**З повагою,
завідувач відділу**

Василь ШЕВЧУК

Наталія Цюрось 0976097388